ANTI-EMETICA BELEID

Bij Chemotherapy Induced Nauseau and Vomiting (CINV)



HOOG EMETOGEEN (>90% kans op CINV in afwezigheid profylaxe)

Carboplatine
Cisplatine
Cyclofosfamide >1500mg/m²
Cytarabine IV vanaf 3g/m²
Dacarbazine
Dactinomycine IV ≥ 1,35 mg/m2
Doxorubicine
Methotrexaat IV ≥ 12g/m²
Melphalan IV
Thiotepa IV ≥ 300mg/m²

Combinatie:
Cytarabine/Daunorubicine of Etoposide
Cyclofosfamide/anthracycline
Cyclofosfamide/anthracycline/Etoposide
Ifosfamide/Etoposide

Ondansetron (3x/d)
+
Dexamethasone
+
Aprepitant
+
Olanzapine (>2j)

MATIG EMETOGEEN (30-90% kans op CINV in afwezigheid van profylaxe)

Arseentrioxide
Azacitidine IV
Bendamustine
Busulfan
Clofarabine
Cyclofosfamide IV≤1500mg/m²
Cytarabine >200mg <3g/m²
Dactinomycine
Daunorubicine
Idarubicine
Ifosfamide
Irinotecan
Lomustine
Methotrexaat IV ≥250mg <12g/m²

Ondansetron (2x/d)
+
Dexamethasone
OF
Aprepitant

LAAG EMETOGEEN (10-30% kans op CINV in afwezigheid van profylaxe)

Asparaginase/Pegasparaginase
ATG
Blinatumomab
Cytarabine <200mg/m² (lage dosis)
Doxorubicine liposomaal
Etoposide
Gemcitabine
Inotuzumab ozogamicin
Methotrexaat <250mg/m² of IT
Mitomycine
Mitoxantrone IV
Temozolomide
Thiotepa <300mg/m²
Topotecan
Triple IT/ITT
Vinblastine
Vincristine
Vinorelbine

Ondansetron (1x/d)

MINIMAAL EMETOGEEN (<10% kans op CINV in afwezigheid van profylaxe)

Bevacizumab
Bleomycine
Bortezomib
Cladribine
Fludarabine
Gemtuzumab ozogamicin
Methotrexaat <50mg/m²
Nelarabine
Rituximab
Thioguanine

Geen standaard profylaxe

ANTI-EMETICA BELEID

Bij Chemotherapy Induced Nauseau and Vomiting (CINV)



ALGEMENE INFO

DOEL = nausea en braken voorkomen tijdens acute fase (vanaf 1e toediening t.e.m. 24u na laatste toediening chemotherapie) en late fase (eerste 96u na de acute fase)

START PROFYLAXE

- De meest emetogene chemotherapie bepaalt het profylaxe-niveau
- Start toediening anti-emetica 30 min. (IV) tot 60 min. (PO) voor eerste toediening chemotherapie
- Consulteer EPD voor eventuele voorgaande CINV-profylaxe

STOP PROFYLAXE

- Ondansetron:
  - Matig- en hoog emetogeen: t.e.m. 3 dagen na laatste chemotherapie
  - Laag emetogeen: enkel op dagen van chemotherapie
- Dexamethasone: enkel op dagen van chemotherapie
- Olanzapine: t.e.m. 3 dagen na laatste chemotherapie

DOORBRAAK NAUSEA & BRAKEN

= optreden van nausea en/of braken tijdens de acute en/of late fase ondanks geschikte CINV-profylaxe (zonder andere oorzaak)

- Verhoog frequentie ondansetron naar 3x/d voor matig emetogeen – 2x/dag voor laag emetogeen – 1x/d voor minimaal emetogeen
- Onvoldoende respons: overweeg opstart olanzapine (>2j)
- Onvoldoende respons: associatie alizapride of lorazepam
- Volgende chemotherapie cyclus: start met hoger profylaxe niveau

ANTICIPATOIR NAUSEA & BRAKEN

= optreden van nausea en/of braken voor aanvang van een nieuwe cyclus chemotherapie

- Niet-farmacologische maatregelen (o.a. relaxatie)
- Associatie lorazepam

OPMERKINGEN

GEEN dexamethasone: indien kuur al corticoïden bevat, bij hersentumoren, bij ALL behandeling, bij dinutuximab beta

5HT3-ANTAGONIST

ONDANSETRON

IV/PO: 5 mg/m² (max. 8 mg/dosis) max. 3x/d
Bij ontslag: 2x/d PO, patiënten doorverwijzen naar ziekenhuisapotheek

PALONOSETRON (enkel in overleg met supervisie/apotheek)

IV: <17j. 20 mcg/kg (max. 1500 mcg/dosis) eenmalig
≥17j. 250 mcg/dosis eenmalig op D1, indien nodig herhalen op D4
= langwerkende vorm, niet samen met ondansetron (tot 3 dagen na toediening palonosetron)
Switch ondansetron → palonosetron bij onvoldoende controle van hoog emetogene kuren

CORTI-COÏDEN

DEXAMETHASONE

IV/PO: <0,6m² 1mg 2x/d (*i.c.m. (fos)aprepitant) OF* 2mg 2x/d *(zonder (fos)aprepitant)*
≥0,6m² 2mg 2x/d *(i.c.m. (fos)aprepitant)* OF 4mg 2x/d *(zonder (fos)aprepitant)*
GEEN voorkeur bij kuur met corticoïden/ALL/AML/hersentumoren/CAR-T patiënten
IV Aacidexam® 5 mg/ml bevat ± 4 mg/ml actieve stof → dosis omrekenen

NK1-ANTAGONIST

(FOS)APREPITANT

<6m of ≤6kg: geen indicatie
PO: <12j. 3 mg/kg (max. 125mg) op D1 gevolgd door 2 mg/kg (max. 80mg) op D2 en D3
≥12j. 125mg op D1 gevolgd door 80mg op D2 en D3
IV: 3 mg/kg (max. 115mg) op D1 gevolgd door 2 mg/kg (max. 80mg) op D2 en D3
OF: >6m - <2j. 5 mg/kg (max. 150mg/dosis) eenmalig IV bij eendaagse chemotherapie
≥2j. - <12j. 4mg/kg (max. 150mg/dosis) eenmalig IV bij eendaagse chemotherapie
≥12j.150mg eenmalig IV bij eendaagse chemotherapie.
PO = voorkeur. Terugbetaling afhankelijk van leeftijd. Opgelet voor interacties (CYP3A4/2C9).

ANTI-PSYCHOTICA

OLANZAPINE

PO: <2j. geen indicatie
≥2j. 0,1 mg/kg (max. 5 mg/dosis) 1x/d
Dosis naar beneden afronden tot de dichtstbijzijnde 0,5mg. Inname 1e dosis vlak voor chemotherapie, nadien bij voorkeur 's avonds. Nooit in monotherapie voor CINV-indicatie.

BENZO-DIAZEPINE

LORAZEPAM

IV/PO: 0,025-0,05 mg/kg (max. 2 mg/dosis) elke 6u indien nodig bij doorbraak CINV
OF: 0,04-0,08 mg/kg (max. 2 mg/dosis) avond voor en ochtend van eerste chemotherapie bij anticipatoir CINV
IV-vorm niet terugbetaald

DOPAMINE-ANTAGONIST

ALIZAPRIDE

IV of per os: 1 mg/kg (max. 50mg/dosis) max. 6x/d
Enkel op dagen van chemotherapie

UZA
JULI 2026 VERSIE 2
Koningin Mathilde Moeder- en kindcentrum